Piel, mucosas, ictericia, faneras, circulación colateral y ganglios

SEMIOLOGIA · Clase 13 · seis hallazgos de la ectoscopia que delatan una enfermedad interna

1 · CÓMO SE EXAMINA LA PIEL

Examen de la piel F1
decúbito dorsal, zona descubierta, ambiente templado y luz natural; se recorre toda la superficie

solo se hace con

Métodos F1
solo inspección y palpación; no se percute ni se ausculta

con ellos se valoran los

Siete elementos a valorar
coloración, humedad, espesor, temperatura, elasticidad, sensibilidad y lesiones elementales

2 · EL COLOR: ICTERICIA Y SUS TRES SITIOS

Ictericia F2
amarillo de esclerótica, piel y mucosas por bilirrubina mayor de 2,5 mg% (normal 1,2 mg%)

se ve mejor en la

primero el color: si amarillea

entre 1,2 y 2,5 mg% aún no se ve

si se destruyen hematíes de más

si el hígado falla

si la bilis no drena

si la humedad aumenta

Dónde se ve mejor F2
esclerótica; en mucosas, conjuntiva y frenillo lingual

Entre 1,2 y 2,5 mg% F2
bilirrubina alta sin color visible (el banco dice 2 mg/dL; literatura 🛍️: 2-3)

Prehepática F3 · F16
hemólisis: se destruyen glóbulos rojos de más y sobra bilirrubina antes del hígado; también da anemia

Hepática F3
el hígado no procesa la bilirrubina: hepatitis, cirrosis

Posthepática F3
vía biliar tapada: coledocolitiasis, cáncer de páncreas

si el tinte es rojizo-anaranjado

separa el tipo de ictericia:

separa el tipo de ictericia:

separa el tipo de ictericia:

Ictericia rubínica (🛍️) F4
tinte rojizo-anaranjado de la hepatocelular: hepatitis viral, sífilis

luego las

refuerza la sospecha hepática:

Tipo de ictericia F3
antes, dentro o después del hígado; el banco da solo cirrosis y colédoco

3 · LESIONES, EQUIMOSIS Y SUDOR

Hiperhidrosis F8
aumento de la sudoración

sin causa fisiológica

tras ejercicio, emoción o calor

Fisiológica F8
ejercicio intenso, grandes emociones, ambientes calientes

Patológica F8
fiebre, hipertiroidismo, shock, dolor, simpaticomiméticos

sin enfermedad:

enfermedad o fármaco:

La cantidad de sudor orienta a respuesta normal, enfermedad o fármaco

Lesiones elementales
se describen por tipo, tamaño, contenido y evolución

si nacen en piel sana

Primarias F7
nacen sobre piel sana: mácula, pápula, vesícula, nódulo, tumor, ampolla, pústula

si es una placa de sangre superficial

si se eleva con suero

si derivan de otra lesión

Vesícula F6
~1 cm con líquido seroso; varicela o herpes zóster inicial; la pápula es sólida

Equimosis F5
placa azulada superficial de sangre bajo la piel

es lo contrario de la

su color permite calcular la

Secundarias F7
derivan de otra lesión: costra, úlcera, escama y cicatriz (tejido fibroso que repone lo destruido)

Edad de la equimosis F5
se deduce de su color

su ejemplo típico es la cicatriz:

al principio es

La **cicatriz** es la excepción; no nace en piel sana, es secundaria F7

Roja y violácea F5
rojiza hasta 48 h; violácea entre 48 y 96 h

luego se vuelve

Azulada F5
5.º-6.º día

al final se vuelve

Amarillenta al 6.º-8.º día; piel normal después del 9.º F5

en los dedos se miden las

4 · UÑAS Y TEJIDO SUBCUTÁNEO

bajo la piel está el

Tejido celular subcutáneo F12
bajo la dermis; se explora pinzando el pliegue y deslizando la piel

su red vascular puede mostrar

puede ser asiento de

Qué lo afecta F12
celulitis (infección), fibroma, lipoma, quiste sebáceo y enfisema; el banco dice linfomas

Uñas F9
forma, ángulo, superficie y color; normal con ángulo menor de 160°

si la uña se despega del lecho

si el ángulo supera 160°

Vidrio de reloj y palillo de tambor F9 · F10
ángulo mayor de 160°, uña convexa y dedos en palillo de tambor (hipocratismo)

Onicólisis (🛍️ banco) F11
separación de la uña de su lecho; no figura en la teoría

aparece en la

y en el

además se palpan los

y en la

Cardiopatía congénita cianótica F9 · F10
como la tetralogía de Fallot

Endocarditis bacteriana subaguda F10
el otro dato cardiovascular que da tu docente

Pulmón y otros F9
cáncer de pulmón, broncopatías crónicas (bronquiectasia, fibrosis, TBC), colitis ulcerativa

obliga a buscar:

pero no ocurre en la

obliga a buscar:

obliga a buscar:

Coartación de aorta F9
cardiopatía acianótica: no da hipocratismo (excepción)

El hipocratismo obliga a buscar enfermedad cardiopulmonar de fondo F9 · F10

5 · CIRCULACIÓN COLATERAL TIPO PORTA

Causas F14
cirrosis, fibrosis hepática, trombosis portal y Budd-Chiari (es una causa, no un signo)

Obstáculo venoso
un tronco obstruido desvía la sangre por colaterales

se reconoce sobre todo por la

según el tronco obstruido hay

impiden el paso de sangre y causan

Dirección del flujo
comprimir con dos índices, retirar uno y ver desde dónde se rellena

Cuatro tipos
braquiocefálico, cava superior, porta y cava inferior

Hipertensión portal F13 · F14
la sangre portal no atraviesa el hígado y busca salida por la pared

si obstruye la porta

en la porta va de abajo hacia arriba:

busca salida por la pared y forma la

Tipo porta: cabeza de medusa F13
venas periumbilicales que irradian del ombligo; flujo de abajo hacia arriba

a pie de cama orienta a

La cabeza de medusa orienta a cirrosis e hipertensión portal F13

6 · GANGLIOS: VIRCHOW-TROISIER

Ganglios linfáticos
se describen por localización, tamaño, consistencia, movilidad, sensibilidad y piel suprayacente

se cuantifica su

en la fosa sobre la clavícula

Fosa supraclavicular F15
recoge linfa de órganos intratorácicos e intraabdominales

Tamaño F16
en cm o por comparación (aceituna, limón); el umbral de más de 1 cm es de literatura 🛍️, no de 0,5 cm

a la izquierda forma el

Ganglio de Virchow-Troisier F15 · F16
supraclavicular izquierdo, duro y fijo; recibe el drenaje de la cavidad abdominal

no sirve del lado

si es duro y fijo sugiere

Neoplasia gástrica metastásica F15
lo que hace sospechar este ganglio

Supraclavicular derecho F15 · F16
no es Virchow ni orienta por sí solo a neoplasia gástrica

técnica · concepto · signo · desenlace · causa · diagnóstico · ejemplo · mecanismo · borde dorado = alto rendimiento · F# = pregunta n.º # de la lámina

Fuente: Sotomayor, Semiología Médica 2020 (05f, 05i, 05j, 08b) — teoría del docente (🛍️ = literatura)